

«Сечокам'яна хвороба»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Вимірювання артеріального тиску за методом Короткова.
- Оцінити клінічний аналіз сечі.
- Оцінити ультразвукове дослідження нирок.
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом сечокам'яна хвороба».

Ви лікар-терапевт приймального відділення. До Вас звернувся чоловік, 36 років, водій.

Скарги: інтенсивний біль у попереку ліворуч, який іррадіює у пахову ділянку, часте та болісне сечовипускання.

Анамнез захворювання: захворів приблизно 4 години тому, коли після порушення дієти (вживав гостру зі спеціями їжу, алкоголь), з'явилися вищераховані скарги. Самостійно приймав анальгін без ефекту, звернувся за допомогою.

Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет заперечує. Протягом життя хворів на ГРВІ. Операції, травми протягом життя – заперечує. Алергійні реакції та непереносимість ліків – заперечує. Шкідливих звичок не має. Спадковість не обтяжено.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості, неспокійний, не може знайти зручне положення, тримається за поперек. Температура тіла 36,6°C. при аускультації легень – везикулярне дихання. ЧДР 16 за 1 хв. Тони серця ясні, ритмічні. ЧСС 98 за хв. Пульс 98 за хв. Симптом Пастернацького позитивний ліворуч. Сечовипускання часте, болюче. Випорожнення без особливостей.

- Додаток 1 Клінічний аналіз сечі

Показник	Результат	Норма
Кількість, мл	130	
Колір	Світло-жовтий	Світло-жовтий
Прозорість	Прозора	Прозора
Питома вага	1,022	1,010-1,040
Реакція	Слабо-кисла	
Білок, г/л	0,05	До 0,14
Глюкоза, ммоль/л	Не знайдено	
Мікроскопічне дослідження		
Еритроцити	4-5 в полі зору	-

Лейкоцити	10-12 в полі зору	6-8 в полі зору
Плоский епітелій	Поодинокі в полі зору	Поодинокі в полі зору
Епітелійперехідний	-	Поодинокі в полі зору
Епітелійнирковий	-	Поодинокі в полі зору
Циліндри:		
- гіалінові	-	-
- зернисті	-	-
- епітеліальні	-	-
- восковидні	-	-
Слиз	Невелика кількість	-
Солі	Багатоуратів	-
Бактерії	-	-

- Додаток 2 Ультразвукове дослідження нирок (ліва нирка)
Заключення: В воротах лівої нирки визначається гіперехогенне утворювання розміром 2,0 на 1,5 см, з акустичною доріжкою за ним.



3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):	
	Інформовану згоду отримано;
	Обробити руки та мембрану фонендоскопу на гігієнічному рівні.

2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ МЕТОДОМ КОРОТКОВА»	
	Коректно (на рівні серця) розташувати руки пацієнта та перевірити манометр
	Коректне (на оголене плече, нижній край манжети розташувати на 2-3 см вище за ліктьовий згин) накладання манжети
	Коректно (центр ліктьової ямки) розташувати акустичну голівку фонендоскопа
	Накачати повітря у манжетку
	При стравлюванні повітря з манжетки зафіксувати рівень систолічного (поява першого тону Короткова) та діастолічного (зникнення тонів Короткова) артеріального тиску. Сказати артеріальний тиск: 160/90 мм рт.ст.
	Зняття манжети
	Самопочуття пацієнта задовільне
3. ДІАГНОСТИКА:	
<i>Оцінити клінічний аналіз сечі (Додаток 1)</i>	Помірна лейкоцитурія (10-12 в полі зору), мікрогематурія та кристалурія (уратурія), що свідчить про уролітіаз.
<i>Оцінити ультразвукове дослідження нирок (ліва нирка) (Додаток 2)</i>	В воротах лівої нирки визначається гіперехогенне утворення розміром 2,0 на 1,5 см, з акустичною доріжкою за ним, що свідчить про конкремент.
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Сечокам'яна хвороба: конкремент лівої нирки. Ниркова колька.
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ	
<i>Призначено наступні ліки:</i>	Для усунення болю при нирковій кольці: Міотропніспазмолітики Нестероїдні протизапальні препарати Розглянути можливість хірургічного лікування
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:	
	Для профілактики утворення конкрементів у нирках щодобове вживання води має бути достатнім для забезпечення обсягу сечі не менше ніж 2,5л на добу. Обмеження вживання продуктів з підвищеним вмістом оксалатів та кальцію, тваринного білка